ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

早期離床 — 要約

解説「早期離床」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

ベッド安静を既定にしない

筋は入室した日から壊れる。入室2〜3日以内に動かし始める

時間ではなく高さで管理

離床時間を延ばしても転帰は動かなかった。その日の最高IMSを記録し、立位を目指す

強度は一律にしない

昇圧薬・深い鎮静・糖尿病が重なれば高用量を課さない。低酸素は椅子に出さない理由にしない

2 動かさない代償と、測る3つの物差し

詳しく

- **筋は入室して数時間で壊れ始める**：ICU-AWは人工呼吸患者の約半数。初週に筋量の約15%を失い、喪失は週を追って加速する（大腿四頭筋は第1週1日約2%、第2週約3%）
- **「作れない」のではなく「壊しすぎる」**：筋線維は約22%小さく、合成は健常と差がなく分解だけが高い。第一手は不要な深鎮静・筋弛緩薬・ステロイドを減らし、不動の日数を短くすること
- **障害は退院で終わらない**：5年生存者の37.7%に運動能力の異常が残り、その60.2%は筋が制限因子。勝負は退室後の1年まで続く

物差し	線	使い方
筋力（MRC）	48未満で診断、55以下でも長期予後に響く	ICU-AWは除外診断。非対称・眼症状・散瞳・自律神経症状があれば別の疾患を探す。退室時の値を申し送る
到達（IMS）	2以上がベッド外、4（立位）が効果の線	毎日「その日の最高IMS」を1項目記録する
参加（RASS）	−2〜0	−3以下の日は離床を強める相談ではなく、鎮静を浅くできるかの相談。鎮痛が先

3 エビデンス — 推奨は「通常より多く」、試験は「時間を延ばす」を否定した

詳しく

- **PADIS 2025**：施設の通常より強化した離床を条件付きで提案。58 RCT・8,038例でICU-AWはRR 0.77（100人あたり9人減、高確実性）。強い推奨のあるガイドラインはない
- **TEAM（750例）**：1日21分を9分と比べても180日の転帰は変わらず、有害事象が増えた
- **平均ゼロの下に利益と害**：TEAMの個別効果の解析で害側を特徴づけたのは昇圧薬・深い鎮静（RASS中央値−4）・糖尿病。IMS 2止まりで長いセッションを重ねると28日死亡が増え、IMS 4以上に届けば害は消えた
- **EVER（169例）**：量を2.75倍にしても機能は動かず、立位に届いた患者だけが良かった（予後の反映かもしれない）
- **矛盾しない**：通常が低ければ上乗せが効き、すでに動いていれば時間を足しても効かない。まず自施設の通常が端座位・立位まで届いているかを確かめる

4 どう動くか — 今日の上限は3点で決める

詳しく

朝の回診：鎮痛とRASSを確かめ、昇圧薬・鎮静・糖尿病の3点で今日の上限を決め、「今日の目標IMS」と中止基準を宣言する。夕方に最高IMSを記録

▼

強度を上げる

- 3点とも当てはまらない（予定手術後など）：立位（IMS 4）以上を狙い、頻度と時間を上げる
- 酸素化が悪い自発呼吸：控える理由にならない。椅子座位の候補

上限を決める・上げない

- 昇圧薬が増量中なら強度を上げる判断を保留。RASS −3以下なら先に鎮静を相談
- 3点が重なる：IMS 0〜2にとどめ、20分超のセッションを重ねない

3点はTEAM試験の二次解析と総説の整理による。RCTで検証された閾値ではない。

- **安全基準は施設の手順で文書にする**：例はEVER（RASS −2〜+1、PEEP 10未満・FiO_2 0.6以下、SpO_2 90%超、収縮期90〜200・平均65〜110、心拍60〜130、昇圧薬を増量していない）
- **ノルアド下で危ないのは起き上がる瞬間**：有害事象は1%で用量と関連せず、ベッド外（OR 3.3）と関連。目安はベッド上0.33・ベッド外0.20 μg/kg/分（検証された安全域ではない）。唯一の重篤事象は0.14で起きた
- **椅子に3時間でP/F差26**：椅子＋13・ベッド−13。受動移乗でも同じで重篤な有害事象はゼロ。ただし軽微な事象は増えるので、出してからが観察の本番
- **機器より人と時間**：NMESはICU-AW RR 0.48だが在室日数・死亡は動かず、離床の代わりにとどまる

5 特殊な集団と落とし穴

詳しく

- **体格・気管切開・フレイルで控えない**：BMI 40以上でも早期歩行は安全で実行可能。スピーチバルブを着けたまま運動してよい。フレイル患者は同じ指示でも動ける量が少なくなる
- **脳卒中は別**：発症24〜48時間に段階的に始め、24時間以内の高用量は行わない（COR 3: Harm）

- ☐ **酸素化が悪い**から離床は明日、にしない
- ☐ **全員を強く**動かさない
- ☐ **時間**ではなく到達の高さで指示する
- ☐ **筋力低下**はまず左右対称かを見る

出典：本編の主要文献（PADIS 2018・2025；TEAM NEJM 2022；TEAM二次解析 ICM 2025・AJRCCM 2024/2026；EVER ICM 2026；Hodgson ICM 2026；Latronico Crit Care 2023；Lindholz Crit Care 2022；Fossat ICM 2026；Nakanishi CCM 2023 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。